

Метафизарные корковые дефекты длинных трубчатых костей в период их роста

Хуснутдинова Г.И., Савхатов Д.К.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г. Алматы

Мақалада өсу кезіндегі ұзын қуыс сүйектердің метафизарлық қабықша ақауларф бойынша қысқаша мәліметтер мен негізінен өс кезеңдегі ұзын қуыс сүйектердің рентгенограммасы бойынша өзіндік клиникалық консультациялық материалдың талдауы берілген (32 байқа).

Жұмыста диагностикалаудың қателектері мен қиындықтары, сонымен қатар өзіндік байқаулары бойынша метафизарлық қабықша ақауларының ағымдық ерекшеліктері көрініс тапқан.

Цель

- дать краткие сведения по диагностике метафизарных корковых дефектов длинных трубчатых костей в период их роста.

Задача

- на основе собственного клинического консультативного материала дать анализ по метафизарным корковым дефектам длинных трубчатых костей.

Основной анализ проведен по рентгенограммам и КТ костей скелета (КТ в единичных случаях).

Поверхностные лакуны костной ткани, известные в литературе, как «метафизарные фиброзные корковые дефекты» благодаря радиографическим методам исследования (главным образом, обычной рентгенографии, линейной и компьютерной томографии) стали довольно часто наблюдаться при исследовании костей по различным мотивам (травма, опухоль или какое-либо другое заболевание).

Обнаруженные случайно кортикальные дефекты становятся нередко причиной серьезных диагностических ошибок и клиницистов и радиологов и гистологов. Так, например, их принимают за внесуставные туберкулезные очаги, костную кисту, гигантоклеточную опухоль, фиброзную дисплазию, абсцесс Броди, эозинофильную гранулему, костную саркому.

Гистологически обычно они расцениваются как «остеобластокластома» или «фиброзная дисплазия», «веретенноклеточная» саркома (Виноградова Т.Т., 1964).

По мнению Некачалова В.В. (2000) микроскопически ткань кортикального дефекта состоит из коллагеновых волокон, тесно прилегающих друг к другу. Между волокнами выявляются фиброциты, а также гигантские клетки, напоминающие остеокластомы, макрофаги и близок к «неостеогенной фиброме».

Между тем, научные исследования последних лет указывают на то, что кортикальные дефекты являются анатомическим вариантом развития костей у детей и не требуют специального лечения (Kaats' Th.E., Joyce Th.M., 1984).

В этом аспекте чрезвычайно важно привлечь внимание широкого круга врачей к данной проблеме. Терминология данного состояния подробно изложена в монографии Квашниной В.И. (1971). Есть указания М.В. Волкова (1985), что субпериостальная форма неостеогенной фибромы при ее краевом расположении развивается из метафизарного коркового дефекта. По мнению С.Т. Зацепина (2000) метафизарный кортикальный дефект, наблюдаемый у детей, чаще ничем себя не проявляющий и не имеющий никакой

In article brief data on diagnostics metaphysical cortical defects long. Tubular bones during their growth and the analysis own clinical. Advisory material basically under roentgenograms of long tubular bones. In the period of their growth (32 supervision).

In work mistakes and difficulties of diagnostics, and also feature of current are reflected metaphysical cortical defects on own supervision.

семиотики, обнаруживаемый случайно на рентгенограммах является неопухолевым диспластическим процессом.

Этиопатогенез

До сих пор нет единого мнения о природе метафизарных корковых дефектов. Можно согласиться с теми исследователями, которые считают, что корковые дефекты это состояния патологической костной перестройки (Рейнберг С.А., 1964; Богоявленский И.Ф., 1976; Хуснутдинова Г.И., 1980).

Существуют мнения о метафизарных корковых дефектах у детей как о множественных очагах варианта развития, как о нормальном анатомическом варианте развития растущих костей, наблюдающихся у совершенно здоровых детей и подростков ((Kerts Jh.E., M.D. and Joyce M.D., 1984).

Клиника Квашнина В.И. (1971) считает, что кортикальные лакуны -заболевание растущего скелета, чаще в возрасте от 5 до 15 лет, могут быть обнаружены и у взрослых и даже у пожилых людей.

Терние их чаще бессимптомное, редко отмечается выраженный болевой синдром, чаще исследуются мальчики в связи с травмой, отсюда их преобладание по сравнению с девочками. Лабораторные исследования без отклонений от нормы.

Рентгенологическая картина

метафизарного коркового дефекта характерна: типичное проявление в виде краеобразующего при выведении на контур дефекта в корковом слое неправильно-овальной формы с полициклическими контурами и склеротическим ободком, расположенного по длиннику кости, обычно в метафизарных отделах длинных трубчатых костей, чаще всего от 0,5см x 1,0 см, реже крупнее, гомогенно просветленной структуры в зависимости от степени выраженности или отсутствия костной репарации на момент исследования.

Иногда возможно вздутие истонченного контура коркового слоя, однако периостальная реакция не характерна.

Собственный консультативный материал составляет 32 наблюдения с метафизарными корковыми дефектами. Наиболее часто корковые дефекты наблюдались в бедренной кости (14)) большеберцовой (13), реже малоберцовой (3), редко плечевой (1) и в лучевой (1) костях с обеих сторон с заметным преобладанием в дистальном метафизе большеберцовой кости.

Из таблицы 1 видно, что метафизарные корковые дефекты встречаются у детей в подростковом и юно-

Таблица 1. Распределение числа наблюдений с метафизарными корковыми дефектами по полу и в возрасте

Пол	Возраст (в годах)			
	До 10	11-15	16-10	Всего
Мужской	3	8	12	23
женский	1	3	5	9
Итого:	4	11	17	32

Таблица 2. Распределение числа наблюдений с метафизарными корковыми дефектами по полу и локализации

Локализация в костях	Всего	Локализация в метафизах длинных в трубчатых костях			
		Муж.	жен	Муж.	жен
		проксим.	проксим.	дистальн	дистальн
бедренная	14	1	3	7	3
большеберц.	13	4	4	3	2
малоберцу	3	1	1	1	-
плечевая	1	1	-	-	-
лучевая	1	-	1	-	-
пяточная	1	-	-	-	-
седалищная	1	-	-	-	-
	34*	14	9	4	5
		32			

* - Примечание: у 2-х - двойная локализация в костях

шеском возрастах: до 10 лет - у 4, с 11 до Yd- у 11, с 16 до 20 лет - у 12, а именно в периоде роста костей скелета. Самого младшего возраста была девочка 2-х лет. Распределение числа наблюдений с корковыми дефектами по полу и локализации представлено в таблице №2.

Из таблицы № 2 видно, что несколько преобладала локализация в дистальной метафизе бедренной (7) и проксимальном метафизе большеберцовой (4) костей. В других костях одиночные наблюдения встречались как в проксимальных, так и в дистальных метафизах трубчатых костей (малоберцовой, плечевой и лучевой), редко - в других костях (пяточная -1, седалищная кость- 1).

Наблюдения показывают, что метафизарные корковые дефекты возникали неизменно в метафизе длинной трубчатой кости и в динамике с ростом кости в длину как бы отодвигались в метадиафиз и даже в диафиз постепенно, подвергаясь костной репарации.

Рентгенограммы в динамике за 6 мес, 1,5 года и 3 года показали заметную костную репарацию в виде появления краевого реактивного характера остеосклероза за счет эндо-ста и структурной перестройки в зоне фиброзных дефектов.

Ошибки и трудности диагностики по собственным наблюдениям

При направлении на консультацию ставились следующие диагнозы: туберкулезный остит бедренной кости -1, остеомиелит бедренной кости -1, повреждение мениска - 1, ушиб, разрыв связок голеностопного сустава -1, патологический перелом -2 (большеберцовой кости -1, лучевой -1), абсцесс Броди обеих бедренных костей -1, фиброзная дисплазия -2, абсцесс Броди большеберцовой

кости -1, асептический некроз большеберцовой кости -1, инфекционно-аллергический полиартрит -1, саркома Юинга большеберцовой кости -1.

К трудностям следует отнести одно наблюдение при типичной рентгенологической картине коркового дефекта большеберцовой кости у мальчика 13-14 лет в сочетании с зоной Лоозера в малоберцовой кости гистологическое заключение было - «остеоид - остеома».

Особенности течения метафизарных корковых дефектов в собственных наблюдениях:

1. Метафизарный корковый дефект бедренной кости наблюдался в сочетании с болезнью Кёнига у юноши 17 лет.
2. Корковый дефект проксимального метафиза плечевой кости в сочетании с врожденной деформацией П-Ш пальцев кистей у подростка 15 лет.
3. Корковый дефект метафиза лучевой кости наблюдался с аналогичным дефектом в 1 пяточной кости у подростка 14 лет.
4. Двусторонняя локализация в дистальных метафизах бедренных костей у подростка 13 лет.
5. Метафизарный корковый дефект в разных костях (в бедренной и большеберцовой) у юноши 16 лет.
6. Операция предпринималась по поводу фиброзной остеодисплазии нижней трети бедренной кости подростку 13 лет, ^рентгенологически оценивался как метафизарный корковый дефект, гистологическое заключение - фиброзный корковый дефект.

Закключение. Несмотря на то, что метафизарные корковые дефекты в настоящее время радиологически хорошо изучены, распознавание их возможно лишь при знакомстве с ними. Ошибки и трудности в диагностике их имеют место, как в клинической, так и рентгенологической оценке. Особенно трудна их гистологическая оценка.

Что касается их сущности: заболевание растущей кости или вариант развития не так уж важно. Важно, что они исчезают без всякого лечения при динамическом наблюдении и не являются опухолевой природы.

Путаницу в диагностике метафизарных корковых дефектов вносят, к сожалению, и клиницисты, и рентгенологи, и гистологи. Поэтому диагностика метафизарных корковых дефектов должна быть комплексной, главным образом, клинко-рентгенологической и гистологической, здесь требуется профессионализм.

Список использованных источников

литературы

1. Богоявленский И.Ф. Патологическая функциональная перестройка костей скелета. М.: Медицина, 1976.-С. 110-117.
2. Виноградова Т.Т. Диагностика костно-суставной патологии по биопсиям. М., 1964.-С.178-181.
3. Волков В.В. Болезни костей у детей. Мю: Медицина, 1985.-364 с.
4. Зацепин С.Т. Костная патология взрослых. М.: Медицина, 2001.-С.213-216.
5. Квашкина В.И. Дифференциальная диагностика метафизарных корковых дефектов трубчатых костей. Ташкент, 1971.
6. Th.E.Keats' M.D., Ju.M.Joyce M.D. Metaphyseal cortical irregularities in children: A new Perspective on a Multi-Total growth variant //Skeletal Radiology.-1984.-№ 12.-С. 112-118.